DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JESSICA ANDREA RODRIGUEZ SANCHEZ **Identificación** CC 1116276026
Edad: 29 AÑOS **Empresa:** SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. SUBSIDIADO-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	Y85	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: K20X ESOFAGITIS

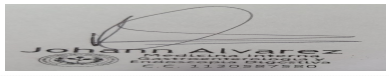
Dx Postoperatorio: K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 13:20:00 **Hora Final** 13:32:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Ingesta de caustico hace 28 horas
ESOFAGO: Dede cricofaringeo hasta tercio distal de esofago se evidencian multiples esfacelaciones, asociado a mucosa hiperemica y erosiones. En UEG se evidencia ulcera profunda sin sangrado. Cardias franqueable.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales. Mucosa de fondo y cuerpo proximal con multiples erosiones diseminadas, En cuerpo gastrico medio y distal hacia la curvatura mayor marcada zona de hiperemia con ulcera extensa con zonas de profundizacion y necrosis escasa. No sangrado activo. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: No se toma por evento agudo
***CONCLUSION:
1. ESOFAGITIS ZARGAR IIa
2. GASTRITIS POR CAUSTICOS ZARGAR IIb

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***